

INDICADO POR: Dr. Claudio Watanabe
() ACOMPANHAMENTO ☒ CONSULTA
NS

DALVA MADALENA PENELUPPI CORREA

IDADE: 43 PESO: 62 ALTURA: 1,60 PROFISSÃO: Professora (aproximada)
SINTOMAS: Sonolência diurna, cansaço.

QUEIXAS: Perda de memória

MEDICAMENTOS: Recontu / Probiom / Trepte / Diupress / Gardiance
Quilage / Rensquinal

MÉDICO: Dr. Claudio Watanabe

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x hidro / muralapão

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: JANTAR: 18h

HORA QUE DORME: 22h HORA QUE ACORDA: 5:30h

COCHILHO (☒) S () N DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: () S () N / DORMEM NO QUARTO: () S () N PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (☒) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO/NOITE: 0

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: normal CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IAH: 22,6 e/h SPO2: 75% mínima

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Edema MMII ao fim da dia / HAS

CIRURGIAS: (☒) NASAL (☒) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (☒) RESPIRATÓRIA (☒) ENDÓCRINA (☒) CARDÍACA

(☒) ORTOPÉDICA (☒) NEUROLÓGICA () OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: () S () N SPO2 C/ CPAP: PRESSÃO NO EXAME:

25/03/25 Análise - foi utilizado CPAP por ± 3 anos

P = 5,5 cm H₂O

IAH = 0,9 e/h

mda leve: 7h

Vacou por 3 dias
antes da consulta
Natacha

28/04/25 P = 5,5 cm H₂O

IAH = 0,4 e/h

muco: 2,4 e/h 6h 50 min

* teve tubo.

sugiro Biologix na próxima
consulta

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (12), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório (22,6 n°/h) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação mínima da oxi-hemoglobina (75%);
3. Latência para o início do sono (21,5 min) (VN= 5 a 30 min);
4. Latência para o início do sono REM (86,5 min) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono (92,1 %) (VN= ≥ 85%);
6. Índice de despertares 12,8 n°/h (VN= até 15 n°/h);
7. Percentual do estágio N1 (2,3 %) (VN= 2% a 5%);
8. Percentual do estágio N2 (48,5 %) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta (14,9 %) (VN= 13% a 23%);
10. Percentual do estágio REM (34,3 %) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco constante, verificado via sensor de ronco;
12. Presença de alteração do ritmo cardíaco. (pág. 10). - (9)

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

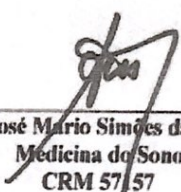
Exame evidenciando aumento do Índice de Distúrbio Respiratório de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Nome: DALVA MADALENA PENELUPPI CORRÊA

Data do Exame: 02-03-2025